

¿CÓMO INFLUYE EL PERSONAL MÉDICO EN LOS ÍNDICES DE EXCLUSIÓN DE LA DONACIÓN DE SANGRE?

Autores: Jorge Pagán Ortiz¹, Josué Pagán², Federico Serrano Valverde¹, Antonia Gómez Simón¹, María Luisa Lozano Almela¹, Vicente Vicente García¹, Francisca Ferrer Marín¹

Centros: ¹Centro Regional de Hemodonación, Murcia, ²Universidad Politécnica de Madrid, Madrid

INTRODUCCIÓN:

Según nuestra legislación; las unidades móviles (UM) y los puntos fijos (PF) de donación están bajo responsabilidad de un médico y los donantes pasarán una valoración médica previa, pudiendo ser suspendida la donación de forma temporal o definitiva. Parte de estos criterios de exclusión son objetivos (nivel de hemoglobina, presión arterial) pero otros son valoraciones médicas subjetivas basadas en la experiencia y el “principio de precaución”, entre otros.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Estudio descriptivo retrospectivo de los ofrecimientos obtenidos según la planificación de las colectas de las UM y de los motivos de exclusión de la donación registrados en el programa Hematos IIG desde 2008-2020.

Los médicos fueron codificados y clasificados según su actividad asistencial principal en atención: **Primaria, Hospitalaria y Donación.**

Según el número de exclusiones, el IE se clasificó en: I) $\leq 10\%$, II) $10-15\%$, III) $15,01-20\%$, IV) $>20\%$.

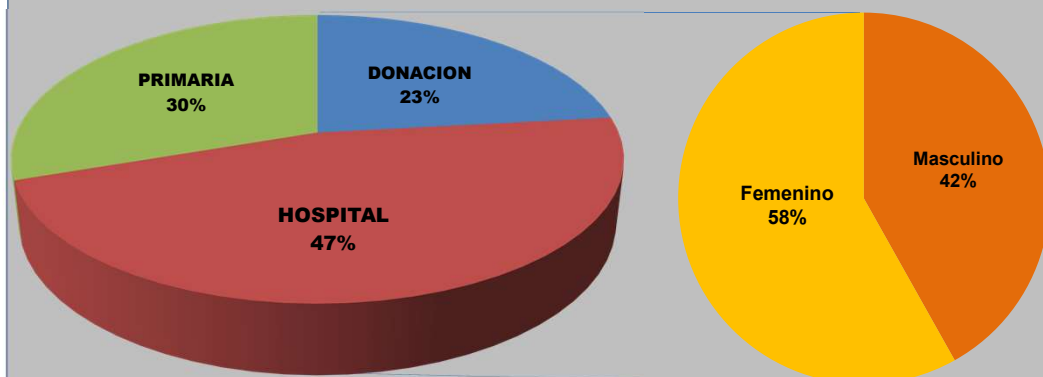
Cuando la previsión fue >70 donaciones, el médico estuvo auxiliado por personal de enfermería formado en reconocimientos.

OBJETIVOS:

Evaluar la influencia del perfil del médico entrevistador sobre los índices de exclusión (IE) y describir los motivos de exclusión más relevantes en nuestra región.



(Gráfico 1)
Distribución de los Médicos por especialidad y sexo



RESULTADOS (I)

Se estudiaron **84.940** motivos de exclusión de **803.780** ofrecimientos realizados en un total de **17.114** colectas.

Participaron **43 médicos** (25 mujeres y 18 varones): 20 de “Hospital”, 13 de “Primaria” y 10 de “Donación” (Gráfico 1).

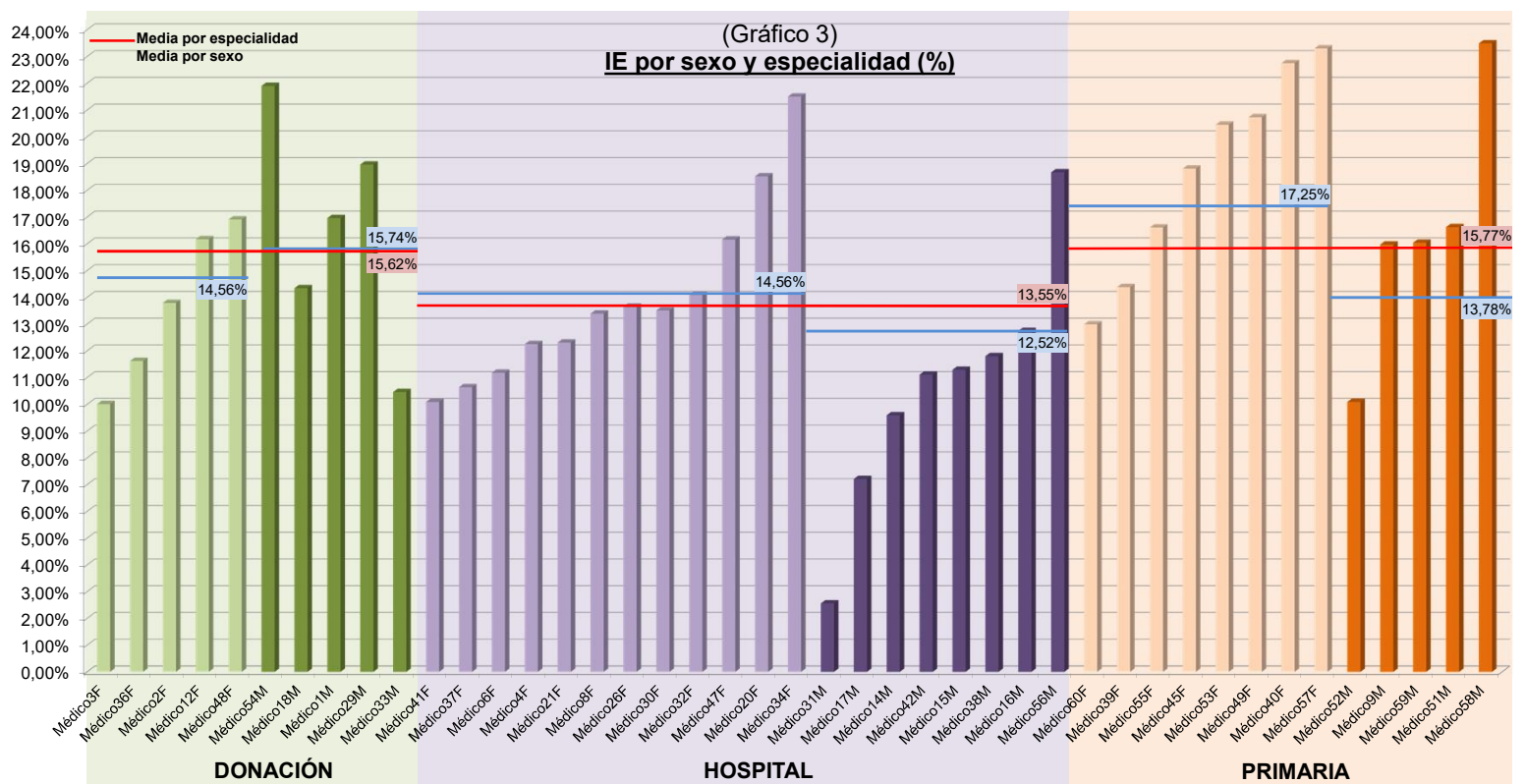
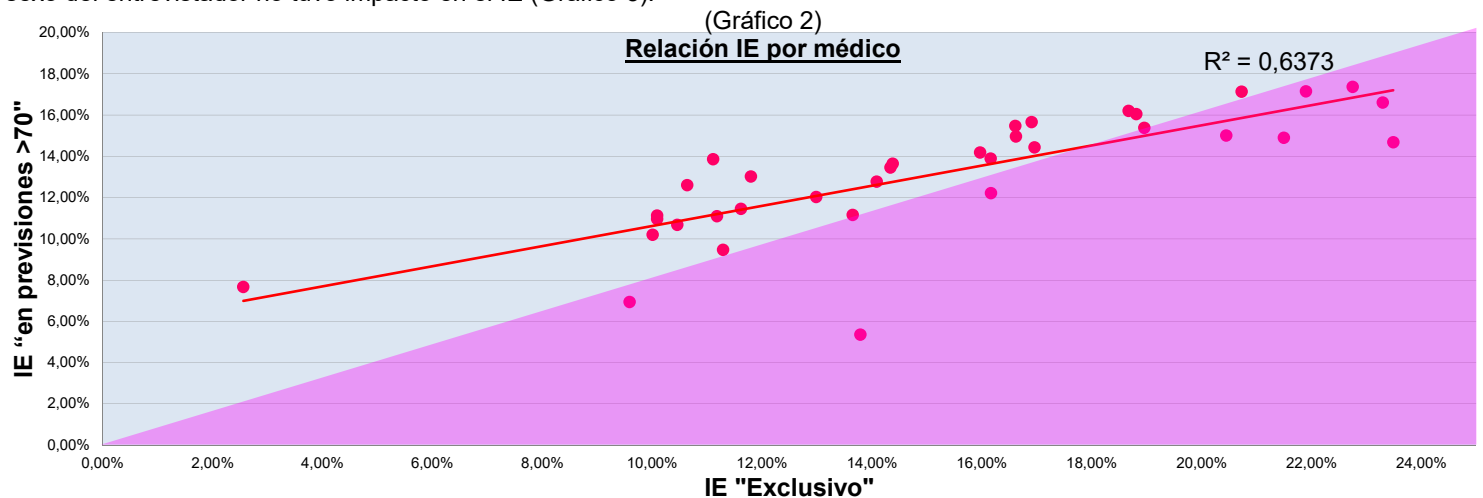
¿CÓMO INFLUYE EL PERSONAL MÉDICO EN LOS ÍNDICES DE EXCLUSIÓN DE LA DONACIÓN DE SANGRE?

Autores: Jorge Pagán Ortiz¹, Josué Pagán², Federico Serrano Valverde¹, Antonia Gómez Simón¹, María Luisa Lozano Almela¹, Vicente Vicente García¹, Francisca Ferrer Marín¹

Centros: ¹Centro Regional de Hemodonación, Murcia, ²Universidad Politécnica de Madrid, Madrid

RESULTADOS (II)

El IE "exclusivo" entre médicos es muy heterogéneo [2,6%-23,5%]. En colectas con previsión <70, el IE aumentó en un 2,7% ($R^2_{\text{Pearson}}=0,66$, $p<10^{-4}$) (Gráfico 2), lo que supuso una pérdida de 18.368 donaciones. Solo 3 de los 43 médicos presentaron un IE "general" <10%. Los médicos de "Hospital" presentaron un IE Medio=13,5% frente a >15,6% de las otras dos especialidades ($p<10^{-6}$). El sexo del entrevistador no tuvo impacto en el IE (Gráfico 3).



¿CÓMO INFLUYE EL PERSONAL MÉDICO EN LOS ÍNDICES DE EXCLUSIÓN DE LA DONACIÓN DE SANGRE?

Autores: Jorge Pagán Ortiz¹, Josué Pagán², Federico Serrano Valverde¹, Antonia Gómez Simón¹, María Luisa Lozano Almela¹, Vicente Vicente García¹, Francisca Ferrer Marín¹

Centros: ¹Centro Regional de Hemodonación, Murcia, ²Universidad Politécnica de Madrid, Madrid

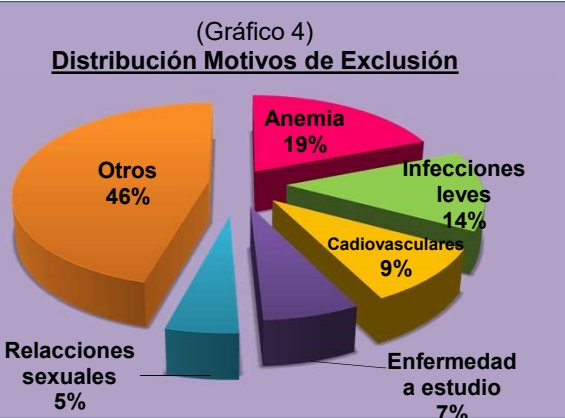
RESULTADOS (III)

El 77% de médicos de “Primaria” presentaron un IE>15%. Este nivel (IE >15%) desciende al 20% entre los de “hospitalaria” (Tabla 1).

También hubo diferencias significativas del IE entre las distintas especialidades médicas en función del tipo de colecta que tutelaran. Así, en colectas para “empresas”, los IE <15% se observaron en el 42,8%, 44,04% y 65% de las colectas tuteladas por médicos de “Donación”, “Primaria” y “Hospitalaria”, respectivamente. En centros educativos, el 56,5% y el 58,2% de los médicos de “Donación” y “Primaria” presentaron IE >20%, frente a solo el 21% de los médicos de “hospital” (Tabla 2).

Especialidad médica	Tabla 1				
	Grado de IE				
	I (≤10%)	II (10-15%)	III (15,01-20%)	IV (>20%)	n
DONACION	1	5	4	0	10
HOSPITAL	3	13	4	0	20
PRIMARIA	0	3	10	0	13
n	4	21	18	0	43

Especialidad médica	Tipo de Colecta	Tabla 2			
		Grado de IE			
		I (≤10%)	II (10-15%)	III (15,01-20%)	IV (>20%)
DONACIÓN	Centro de Salud	19,97%	33,44%	28,19%	18,40%
	Centro Educativo	9,72%	12,22%	21,50%	56,55%
	Empresas/Hospitales	20,11%	22,65%	23,12%	34,12%
	Colectivos/Maratones	11,70%	20,21%	24,47%	43,62%
HOSPITAL	Centro de Salud	34,25%	31,04%	16,15%	18,56%
	Centro Educativo	38,60%	12,28%	28,07%	21,05%
	Empresas/Hospitales	32,61%	32,61%	13,04%	21,74%
	Colectivos/Maratones	13,33%	33,33%	20,00%	33,33%
PRIMARIA	Centro de Salud	20,41%	28,98%	27,83%	22,78%
	Centro Educativo	8,20%	13,93%	19,67%	58,20%
	Empresas/Hospitales	19,05%	25,00%	27,38%	28,57%
	Colectivos/Maratones	10,71%	21,43%	28,57%	39,29%



El motivo de exclusión más frecuente en general fue por anemia, causante del 19% de las exclusiones (16.188 ofrecimientos), seguida de las infecciones leves (13,8%) y cifras inadecuadas de presión arterial y pulso (9,6%) (Gráfico 4).

CONCLUSIÓN:

- Nuestros datos muestran que el tipo de dedicación principal de los médicos que realizan la entrevista (donación, primaria, hospitalaria) influye en el IE.
- Los médicos con especialidades hospitalarias tienden a excluir a menos donantes, en contraste con los de primaria.
- El IE disminuye cuando el médico es auxiliado en las entrevistas.
- Cada vez es más evidente y necesario contar con unos motivos de exclusión más claros y explícitos para evitar la variabilidad de criterios que se está produciendo en la actualidad.